

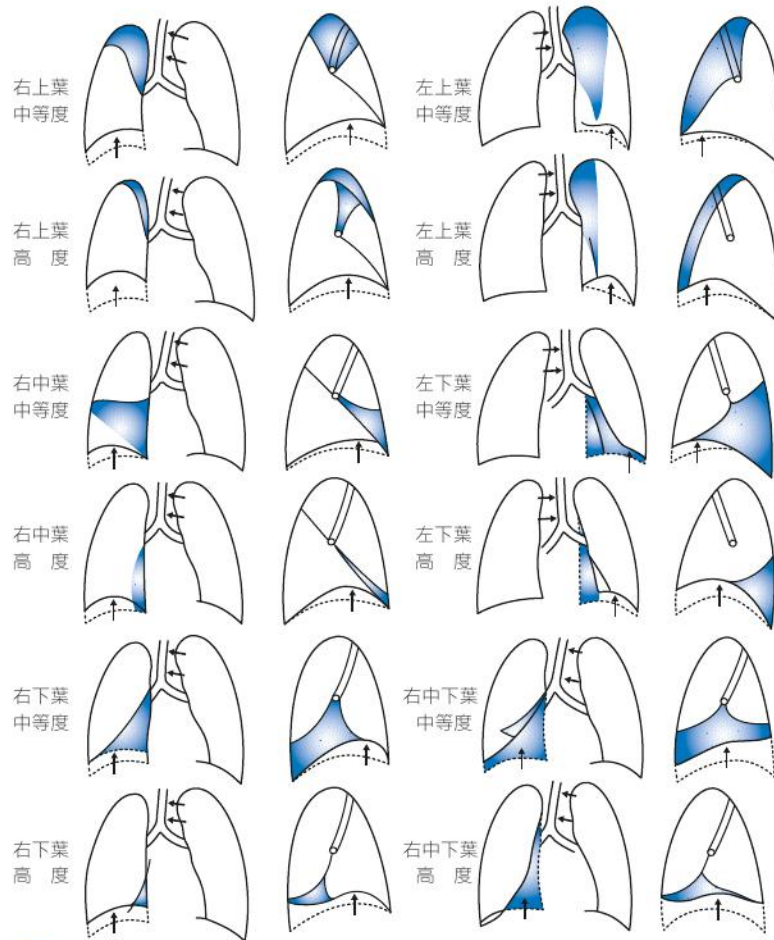


図1 葉性無気肺の画像の特徴と模式図

[楠本昌彦，河野通雄：臨画像 11：86，1995より引用]

iv) 斑状無気肺（patchy atelectasis）

出血や局所的な浮腫により肺胞が液体で埋まり容積が減少している状態。

診 断

a 自覚症状

閉塞性無気肺を生じる病態の一部では，急性の気道閉塞に伴う呼吸困難や胸痛を訴える。閉塞しても特別な自覚症状がない場合もある。

b 身体所見

閉塞性無気肺の場合，無気肺が生じた肺葉の部分の肺音は一般に減弱する。一方で無気肺の部分があることで気管支音がよく聴取されるようになることがある（bronchial breathing）。これは含気を失った末梢肺の部分が胸壁に接し，同時に中枢側の気管支が開いている場合であり，囁き声を出してもらうと通常よりもはっきりと声が聴取される所見（whispering pectoriloquy）が確かめられることがある。

c 画像診断

閉塞性無気肺では閉塞した部分の容量減少によりその部分に陰影が生じることと，容量減少に伴う周囲の構造の偏位が所見となる。気管支・血管陰影の偏位や収束が観察される。中枢側の閉塞による無気肺ではair bronchogramを伴わないが，非閉塞性無気肺で，末梢側の含気の減少から生じる場合には中枢側のair bronchogramを呈することがあり，左下葉でよく経験される。

閉塞性無気肺の診断の手がかりとなる単純X線写真（正面・側面）の特徴を図1でシェーマに，所見を表2に示す。肺葉性無気肺（lobar atelectasis）は，シルエットサインなどにも注意しながら観察することで診断が可能である。

治 療

a 症状への対応

無気肺により呼吸不全が生じる場合がある。特に中枢側気管支の閉塞により無気肺の部位への肺循環の血